

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria Técnica
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Serviços Especiais
Gerências Distritais da Atenção Primária

Nota Técnica Conjunta nº 02/2024 – SES.DAS / SES.DTE

Assunto: Atribuições e Avaliação clínica médica aos usuários com alta suspeita de Deficiência Intelectual (DI) e/ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na Rede de Atenção à Saúde (RAS)

Considerando a instituição do Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro do Autismo-NAIPE DI/TEA (conforme disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informação - SEI N° 22.0.178204-5);

Considerando a validação da Diretoria Técnica da Secretaria da Saúde do Município de Joinville no que se refere às atribuições e competências dos Médicos de Estratégia da Saúde da Família (ESF), Pediatra, Psiquiatra Teleconsultor e Médico da Saúde Mental no que se refere a investigação clínica para suspeita de DI/TEA;

A Diretoria de Assistência à Saúde e a Diretoria Técnica, por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, elaboram e publicam a nota técnica de investigação clínica para suspeita de DI/TEA, que deve ser utilizada pelos profissionais médicos da RAS do Município de Joinville, conforme as seguintes orientações:

ATRIBUIÇÕES:

1. MÉDICO DA ESF

- A.** Garantir o preenchimento atualizado e análise da Caderneta de Saúde da Criança, especialmente com relação aos marcos do neurodesenvolvimento;
- B.** Realizar o preenchimento da Escala *M-CHAT-R* (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised), quando a criança estiver com idade entre 16 a 30 meses (disponível no processo SEI N° 22.0.178204-5 ou através do link:

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Portuguese_Portugal.pdf)

- C. Aplicação do instrumento de avaliação DI/TEA - “**Entrevista Estruturada para Investigação Clínica na Suspeita de DI/TEA - MÉDICO - ESF**” (Anexo 1);
- D. Permanecendo a alta suspeita de DI e/ou TEA solicitar relatório escolar ao encaminhar para o pediatra.

2. MÉDICO PEDIATRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

- A. Conferir o preenchimento atualizado e análise da Caderneta de Saúde da Criança, especialmente com relação aos marcos do neurodesenvolvimento. Caso não exista registro na Caderneta de Saúde, realizar o preenchimento;
- B. Triar a suspeita de DI e/ou TEA através da observação direta no consultório, análise documental preexistente (exames, relatórios, pareceres, etc), queixas e constatações na entrevista com os pais/responsáveis;
- C. Avaliar o desenvolvimento da criança: marcos de desenvolvimento, cognitivo, motor, de linguagem, de habilidades sociais e a avaliações comportamentais que sugiram ou indiquem possíveis sinais de alerta para o diagnóstico de DI e/ou TEA;
- D. Solicitar, se necessário, à Equipe Multiprofissional (eMulti) de referência o auxílio na sua conduta, preferencialmente aos profissionais de Terapia Ocupacional ou Psicologia;
- E. Caso permaneça dúvidas diagnóstica e/ou manejo, pode realizar Teleconsultoria em Psiquiatria para auxílio;
- F. Se outro diagnóstico mais provável, encaminhar para Neurologia Pediatria, conforme protocolo estadual.

3. MÉDICO PSIQUIATRA TELECONSULTOR

O médico psiquiatra teleconsultor pode oferecer suporte para casos com alta suspeita de DI e/ou TEA aos médicos que atuam nas unidades de saúde através de:

- A. Orientação diagnóstica: Auxiliar os médicos da (APS) na identificação de sinais precoces de DI e/ou TEA, fornecendo critérios diagnósticos e orientações sobre a avaliação inicial;
- B. Triagem e encaminhamento: Recomendar ferramentas de triagem e orientar sobre o encaminhamento adequado para serviços especializados de diagnóstico e intervenção, como centros de neurodesenvolvimento ou equipes de saúde mental;
- C. Apoio na intervenção precoce: Fornecer orientação sobre intervenções precoces e estratégias de suporte que possam ser implementadas na APS, como encaminhamento para terapia ocupacional, fonoaudiologia ou programas de intervenção comportamental.

4. MÉDICO DE SAÚDE MENTAL

- A.** Avaliar se há critérios diagnósticos de acordo com o *DSM-5-TR* (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, Texto Revisado) que fundamentam a suspeita e/ou diagnóstico de DI e/ou TEA;
- B.** Avaliar e, se necessário, intervir nas comorbidades psiquiátricas que acompanham o TEA, como a ansiedade, a impulsividade, agressividade, Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade (TDAH), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtorno Desafiador Opositor (TOD), entre outros, principalmente na adolescência;
- C.** Orientações para a família e/ou responsáveis, além do próprio usuário, pois o autismo é um transtorno que afeta a dinâmica da família e pode adoecer também quem convive com essa situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalização das etapas de avaliação, os médicos pediatra e saúde mental, devem encaminhar o usuário com alta suspeita de DI e/ou TEA ao Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com DI/TEA (NAIPE DI/TEA), conforme o Protocolo de Acesso disponível no processo SEI N° 22.0.178204-5.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. **Caderneta de Saúde da Criança: Passaporte da Cidadania**. 12ª Edição. Brasília – DF: 2019;

RIO GRANDE DO SUL. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais - DSM-5**. [American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. – 5. ed. Porto Alegre - RS: 2014;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Nota Técnica Conjunta nº 03/2024 - SES.DAS/DTE**. Implantação do instrumento referente à Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) utilizado pela Equipe Multiprofissional (eMulti) da Atenção Primária à Saúde (APS) para auxiliar os médicos pediatras da unidade de saúde de referência. Joinville - SC: 2024;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro do Autismo - NAIPE DI/TEA**. Joinville - SC: 2024.

Anexo 1. Entrevista Estruturada para Investigação Clínica na Suspeita de DI/TEA - Médico - ESF

ENTREVISTA ESTRUTURADA PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA NA SUSPEITA DE DI/TEA	
MÉDICO - ESF	
Nome do Usuário:	
Data de nascimento:	Idade:
Anamnese respondida por:	
1) Há relato de doença psiquiátrica, consanguinidade ou TEA na família do usuário?	
2) Há relato de intercorrências na gestação - tais como: infecções maternas, sangramentos ou uso de álcool, drogas/medicamentos pela mãe?	
3) História de parto - O usuário foi prematuro, baixo peso (menor que 2,5 kg) ou apresentou sofrimento fetal com APGAR baixo?	
4) Como é o desenvolvimento motor e social da criança?	
5) Sustentou a cabeça até o terceiro mês?	
6) Sorriso social a partir do 2 mês de vida?	
7) Sentou sem apoio até 7 meses de vida?	
8) Estranhou pessoas desconhecidas por volta de 9 meses de vida?	
9) Andou até 1 ano e 4 meses?	
10) Existem preocupações relatadas pelos pais ou cuidadores sobre déficits nas habilidades sociais, déficits de linguagem ou dificuldades a tolerar mudanças de rotinas?	
11) Existe atraso na aquisição de habilidades sociais e de comunicação, como não apontar um objeto de interesse por volta de 14 meses, não brincar de 'faz de conta' aos 18 meses (por ex. brincar que está alimentando uma boneca)?	
12) Evita contato visual ou deseja ficar preferencialmente sozinho de forma insistente?	
13) Apresenta dificuldade de compreender as emoções de outras pessoas ou de falar sobre suas próprias emoções?	
14) Repete frequentemente frases ou palavras (ecolalia)?	
15) Responde a perguntas com respostas não relacionadas ou "aleatórias"?	
16) Apresenta interesses restritos e obsessivos (exemplo: brinca com os mesmos brinquedos ou assiste os mesmos filmes, etc.)?	
17) Apresenta com frequência movimentos como bater as mãos, girar em círculos ou balançar o corpo?	
18) Apresenta com frequência reações incomuns a barulho, cheiro, sabor ou ao toque (alterações sensoriais)?	